

<붙임 2>

건강보험심사평가원 공고 제2026-117호

「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조제4항 규정에 따라 암환자에게 처방·투여하는 약제 중 보건복지부장관이 정하여 고시하는 약제(보건복지부 고시 제2025-73호, 2025.5.1.)에 대한 ‘요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 (건강보험심사평가원 공고 제2026-88호, 2026.4.1.)’을 다음과 같이 개정 공고합니다.

2026년 4월 29일
건강보험심사평가원장

암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 중 개정

암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항을 다음과 같이 변경한다.

부 칙(2026.4.29)

① (시행일) 이 공고는 2026년 5월 1일부터 시행한다.

공고개정 내역

○ 다음의 암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 '요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항' 공고

<신설>

- 신장암에 'Bevacizumab + Erlotinib' 병용요법(1차 이상, 고식적요법)
- 기타 암(진성적혈구증가증)에 'Ruxolitinib' 단독요법

<변경>

- 기타 암(골수증식성질환)에 'Fedratinib' 단독요법 투여대상 문구 추가

□ 공고개정 내역

신설

I. 항암요법

□ 주요 암종별 항암요법

구 분	세부인정기준 및 방법										
13. 신장암 (Kidney Cancer)	13. 신장암(Kidney Cancer)										
	1. 고식적요법(palliative)										
	가. 투여단계: 1차 또는 1차 이상										
	<table><tr><th>연번</th><th>항암요법</th><th>투여대상</th><th>투여단계</th></tr><tr><td>7</td><td>bevacizumab + erlotinib</td><td>재발성, 진행성, 전이성 또는 수술이 불가능한 FH(fumarate hydratase) 결손 신세포암(이전 HLRCC 포함)^{주3}</td><td>1차 이상</td></tr></table>				연번	항암요법	투여대상	투여단계	7	bevacizumab + erlotinib	재발성, 진행성, 전이성 또는 수술이 불가능한 FH(fumarate hydratase) 결손 신세포암(이전 HLRCC 포함) ^{주3}
연번	항암요법	투여대상	투여단계								
7	bevacizumab + erlotinib	재발성, 진행성, 전이성 또는 수술이 불가능한 FH(fumarate hydratase) 결손 신세포암(이전 HLRCC 포함) ^{주3}	1차 이상								
주3. 병리 조직검사상 FH 항체 음성 및 2SC 항체 양성 소견이 확인 또는 종양 조직에 대한 차세대 염기서열 분석(NGS)을 통해 FH 유전자의 불활성화 변이가 있으면 진단											
39. 기타 암											
	<table><tr><th>연번</th><th>대상질환</th><th>항암요법</th></tr><tr><td>11</td><td>진성 적혈구 증가증</td><td> ruxolitinib • 투여대상: hydroxyurea에 resistant 또는 intolerant를 보이는 진성적혈구증가증 ※ HU-resistant/intolerant는 modified ELN 가이드라인을 따름. ※ 다음 중 한 가지 조건에 해당하는 경우 투여 중단함. 1) 투여 6개월 후 HCT(Hematocrit)를 평가하고, 이후 3개월 간격으로 평가하여 2회 연속으로 HCT 반응이 없는 경우(HCT 반응이 없는 경우: 최근 3개월 이내 phlebotomy 시행 이력이 있거나, HCT≥45%인 경우) 2) 질병이 진행한 경우(Post-PV myelofibrosis, Myelodysplastic syndrome, Acute leukemia) 3) 촉지 가능 비장비대 환자에서는 투여 6개월 이후 비장 크기 감소(기준점 대비 35% 이상 감소)가 없는 경우 </td></tr></table>	연번	대상질환	항암요법	11	진성 적혈구 증가증	ruxolitinib • 투여대상: hydroxyurea에 resistant 또는 intolerant를 보이는 진성적혈구증가증 ※ HU-resistant/intolerant는 modified ELN 가이드라인을 따름. ※ 다음 중 한 가지 조건에 해당하는 경우 투여 중단함. 1) 투여 6개월 후 HCT(Hematocrit)를 평가하고, 이후 3개월 간격으로 평가하여 2회 연속으로 HCT 반응이 없는 경우(HCT 반응이 없는 경우: 최근 3개월 이내 phlebotomy 시행 이력이 있거나, HCT≥45%인 경우) 2) 질병이 진행한 경우(Post-PV myelofibrosis, Myelodysplastic syndrome, Acute leukemia) 3) 촉지 가능 비장비대 환자에서는 투여 6개월 이후 비장 크기 감소(기준점 대비 35% 이상 감소)가 없는 경우				
연번	대상질환	항암요법									
11	진성 적혈구 증가증	ruxolitinib • 투여대상: hydroxyurea에 resistant 또는 intolerant를 보이는 진성적혈구증가증 ※ HU-resistant/intolerant는 modified ELN 가이드라인을 따름. ※ 다음 중 한 가지 조건에 해당하는 경우 투여 중단함. 1) 투여 6개월 후 HCT(Hematocrit)를 평가하고, 이후 3개월 간격으로 평가하여 2회 연속으로 HCT 반응이 없는 경우(HCT 반응이 없는 경우: 최근 3개월 이내 phlebotomy 시행 이력이 있거나, HCT≥45%인 경우) 2) 질병이 진행한 경우(Post-PV myelofibrosis, Myelodysplastic syndrome, Acute leukemia) 3) 촉지 가능 비장비대 환자에서는 투여 6개월 이후 비장 크기 감소(기준점 대비 35% 이상 감소)가 없는 경우									

I. 항암요법

☐ 주요 암종별 항암요법

구 분	세부인정기준 및 방법		
39. 기타 암	연번	대상질환	항암요법
	16	골수증식성질환	fedratinib • 투여대상: 이전에 ruxolitinib으로 치료를 받은 성인환자의 다음 질병과 관련된 비장비대 또는 증상의 치료 - 일차성 골수섬유증 - 진성적혈구증가증 후 골수섬유증 - 본태성혈소판증가증 후 골수섬유증 ※ 반응평가기준은 IWG-ELN guideline에 따라 CI(Clinical Improvement) 이상일 경우 투여 지속 ※ 이전에 진성적혈구증가증으로 ruxolitinib을 투여한 경우 포함<추 가>

변 경 대 비 표

I. 항암요법

☐ 주요 암종별 항암요법

구분	개정(전)			개정(후)		
39. 기타 암	연번	대상질환	항암요법	연번	대상질환	항암요법
	16	골수증식성 질환	fedratinib - 투여대상: 이전에 ruxolitinib으로 치료를 받은 성인환자의 다음 질병과 관련된 비장비대 또는 증상의 치료 - 일차성 골수섬유증 - 진성적혈구증가증 후 골수섬유증 - 본태성혈소판증가증 후 골수섬유증 ※ 반응평가기준은 IWG-ELN guideline에 따라 CI(Clinical Improvement) 이상일 경우 투여 지속	16	골수증식성 질환	fedratinib - 투여대상: 이전에 ruxolitinib으로 치료를 받은 성인환자의 다음 질병과 관련된 비장비대 또는 증상의 치료 - 일차성 골수섬유증 - 진성적혈구증가증 후 골수섬유증 - 본태성혈소판증가증 후 골수섬유증 ※ 반응평가기준은 IWG-ELN guideline에 따라 CI(Clinical Improvement) 이상일 경우 투여 지속 ※ 이전에 진성적혈구증가증으로 ruxolitinib을 투여한 경우 포함<추 가>

신 설

I. 항암요법

□ 주요 암종별 항암요법

구 분	세부인정기준 및 방법				배경, 사유 및 근거
13. 신장암 (Kidney Cancer)	13. 신장암(Kidney Cancer) 1. 고식적요법(palliative) 가. 투여단계: 1차 또는 1차 이상				○ ‘Bevacizumab(품명:아비스틴주 등), Erlotinib(품명: 타쎬마정 등)’은 <Fumarate hydratase deficient RCC 환자의 1차 이상 치료에 ‘Bevacizumab + Erlotinib 병용요법>으로 허가는 없으나, 교과서·가이드라인·임상논문 등을 참조하여 검토한 결과, NCCN 가이드라인 (ver 1, 2026)에서 Other Recommended, category 2A로, ESMO(2024)에서 III, B로 권고하고 있음. ○ 전이성, 진행성 유전성 평활근종증 및 신세포암 관련 유두 신세포암 또는 산발성 유두 신세포암을 진단받은 환자, 이전 치료 차수 2차 이하인 환자를 대상으로 한 단일군, 2상 임상 시험에서 HLRCC 관련 유두 신세포암과 산발성 유두 신세포암을 비교한 결과, 객관적 반응률(ORR)은 72%(95% CI 57 - 83) vs 35%(95% CI 22 - 51), 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 21.1개월(95% CI 15.6 - 26.6) vs 8.9개월(95% CI 5.5 - 18.3), 전체 생존기간 중앙값(mOS)은 44.6개월(95% CI 32.7 - NE) vs 18.2개월(95% CI 12.6 - 29.3)로 확인됨. ○ 임상논문 전문가 및 학회의견 등을 종합적으로 고려하여 투여대상을 ‘fumarate hydratase deficient RCC’에 ‘이전 HLRCC 포함’하고, 진단기준을 명시하여, 급여기준을 설정함.
	연번	항암요법	투여대상	투여단계	
	7	bevacizumab + erlotinib	재발성, 진행성, 전이성 또는 수술이 불가능한 FH(fumarate hydratase) 결손 신세포암(이전 HLRCC 포함) ^{주3}	1차 이상	
	주3. 병리 조직검사상 FH 항체 음성 및 2SC 항체 양성 소견이 확인 또는 종양 조직에 대한 차세대 염기서열 분석(NGS)을 통해 FH 유전자의 불활성화 변이가 있으면 진단				

구 분	세부인정기준 및 방법			배경, 사유 및 근거
				○ 관련근거 - NCCN Guideline, version 1. 2026. kidney cancer. - Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up, 2024. - Bevacizumab and erlotinib in hereditaryand sporadic papillary kidney cancer, N Eng J Med 2025;392:3246-56. - Bevacizumab Plus Erlotinib Combination Therapy for Advanced Hereditary Leiomyomatosis and Renal Cell Carcinoma-Associated Renal Cell Carcinoma: A Multicenter Retrospective Analysis in Korean Patients, Cancer Res Treat 2019;51:1549-1556.
39. 기타 압				○ ‘Ruxolitinib(품명: 자카비정)’은 <히드록시우레아에 내성 또는 불내성을 보이는 진성적혈구증가증>에 허가받은 약제로, 교과서·가이드라인·임상논문 등을 참조하여 검토한 결과, 동 요법은 교과서에서 언급되며, NCCN 가이드라인(ver 2, 2025)에서 Preferred regimen, category 1로, ESMO(ver 2015) 가이드라인에서 [I , A]로 권고함. ○ 다기관, 무작위배정 3상 임상시험(RESPONSE)에서 Hydroxyurea에 resistant 또는 intolerant 비장비대증이 있는 진성적혈구 증가증 환자를 대상으로 Ruxolitinib군과 single-agent best available therapy군을 비교한 결과, 종합반응(Composite resposne)이 20.9% v.s 0.9%(OR 28.6, P<0.001)로 확인 되었으며, 5년 추적 연구에서도 종합반응을 유지할 확률이 74%(95% CI 51-88)로 확인됨. 또한, 다기관, 무작위배정 3상 임상시험(RESPONSE2)에서 Hydroxyurea에 resistant 또는 intolerant 비장비대증이 없는 진성적혈구증가증 환자를
	연번	대상질환	항암요법	
	11	진성 적혈구 증가증	ruxolitinib • 투여대상: hydroxyurea에 resistant 또는 intolerant를 보이는 진성적혈구증가증 ※ HU-resistant/intolerant는 modified ELN 가이드라인을 따름. ※ 다음 중 한 가지 조건에 해당하는 경우 투여 중단함. 1) 투여 6개월 후 HCT(Hematocrit)를 평가하고, 이후 3개월 간격으로 평가하여 2회 연속으로 HCT 반응이 없는 경우 (HCT 반응이 없는 경우: 최근 3개월 이내 phlebotomy 시행 이력이 있거나, HCT≥45%인 경우) 2) 질병이 진행된 경우(Post-PV myelofibrosis, Myelodysplastic syndrome, Acute leukemia)	

구 분	세부인정기준 및 방법	배경, 사유 및 근거			
	<table border="1" data-bbox="248 268 1189 347"> <tr> <td data-bbox="248 268 309 347"></td> <td data-bbox="309 268 445 347"></td> <td data-bbox="445 268 1189 347">3) 측지 가능 비장비대 환자에서는 투여 6개월 이후 비장 크기 감소(기준점 대비 35% 이상 감소)가 없는 경우</td></tr> </table>			3) 측지 가능 비장비대 환자에서는 투여 6개월 이후 비장 크기 감소(기준점 대비 35% 이상 감소)가 없는 경우	대상으로 Ruxolitinib군과 single-agent best available therapy군을 비교한 결과, 28주차 hematocrit control이 62% vs 19%(OR 7.28, 95% CI 3.43-15.45, $P<0.0001$)로 확인됨. 또한, 다기관, 무작위배정 2상 임상시험(MAJIC-PV)에서 Hydroxyurea에 resistant 또는 intolerant 고위험군 진성적혈구증가증 환자를 대상으로 Ruxolitinib군과 single-agent best available therapy군을 비교한 결과, 12개월 이내 완전 반응률이 43% vs 26%(OR 2.12, 90% CI 1.25-3.60, $P=0.02$), 무사건 생존율(Event-free survival) HR 0.58(95% CI 0.35-0.94, $P=0.03$)로 확인됨. ○ 주요 임상적 efficacy를 확인하기 위해서는 장기간 추적이 필요한 제한점이 있으나, 질환의 특성상 생존율 개선을 보이기 어려운 점, 치료 옵션이 극히 제한적으로 unmet needs가 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 급여기준을 설정함. ○ 관련근거 - Cancer 12th. - NCCN Guideline, version 2. 2025. Myeloproliferative Neoplasms. - Philadelphia chromosome-negative chronic myeloproliferative neoplasms: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. 2015. - Ruxolitinib versus Standard Therapy for the Treatment of Polycythemia Vera (RESPONSE), N Engl J Med. 2015 January 29; 372(5): 426 - 435. - Ruxolitinib versus best available therapy in patients with polycythemia vera: 80-week follow-up from the RESPONSE trial, Haematologica. 2016
		3) 측지 가능 비장비대 환자에서는 투여 6개월 이후 비장 크기 감소(기준점 대비 35% 이상 감소)가 없는 경우			

구 분	세부인정기준 및 방법	배경, 사유 및 근거
		Jul;101(7):821-9. - Long-term efficacy and safety of ruxolitinib versus best available therapy in polycythaemia vera (RESPONSE): 5-year follow up of a phase 3 study, Lancet Haematol 2020; 7: e226 - 37. - Ruxolitinib for the treatment of inadequately controlled polycythaemia vera without splenomegaly (RESPONSE-2): a randomised, open-label, phase 3b study, Lancet Oncol 2017; 18: 88 - 99. - Ruxolitinib for the treatment of inadequately controlled polycythemia vera without splenomegaly: 80-week follow- up from the RESPONSE-2 trial, Ann Hematol. 2018 Sep; 97(9):1591-1600. - Ruxolitinib versus best available therapy in inadequately controlled polycythaemia vera without splenomegaly (RESPONSE-2): 5-year follow up of a randomised, phase 3b study, Lancet Haematol 2022; 9: e480 - 92. - Ruxolitinib Versus Best Available Therapy for Polycythemia Vera Intolerant or Resistant to Hydroxycarbamide in a Randomized Trial (MAJIC-PV), J Clin Oncol. 2023 Jul 1;41(19):3534-3544.

변경

I. 항암요법

□ 주요 암종별 항암요법

구분	세부인정기준 및 방법			배경, 사유 및 근거
39. 기타 암				○ 현재 급여기준 상 골수섬유증에 Ruxolitinib 이외에 1차로 투여할 수 있는 약제가 없어, 진성적혈구증가증에서 Ruxolitinib 투여 후 골수섬유증으로 질병 진행 시 Ruxolitinib을 재투여하지 않아도 Fedratinib 사용이 가능하도록 급여기준을 변경함.
	연번	대상질환	항암요법	
	16	골수증식성 질환	fedratinib - 투여대상: 이전에 ruxolitinib으로 치료를 받은 성인환자의 다음 질병과 관련된 비장비대 또는 증상의 치료 - 일차성 골수섬유증 - 진성적혈구증가증 후 골수섬유증 - 본태성혈소판증가증 후 골수섬유증 ※ 반응평가기준은 IWG-ELN guideline에 따라 CI(Clinical Improvement) 이상일 경우 투여 지속 ※ 이전에 진성적혈구증가증으로 ruxolitinib을 투여한 경우 포함<추 가>	